

Inducción del parto

1. Introducción y relevancia clínica

La **inducción del parto (IP)** es el **proceso mediante el cual se estimula artificialmente el inicio de las contracciones uterinas regulares**, con el objetivo de **producir la dilatación y el parto vaginal** cuando **la continuación del embarazo supone mayor riesgo que su finalización**.

En Chile, la IP representa entre **15–25% de los partos hospitalarios**, según datos del MINSAL.

El éxito de la inducción depende principalmente del **estado del cuello uterino (índice de Bishop)** y de la **indicación obstétrica precisa**.

□ En EUNACOM, las preguntas más frecuentes giran en torno a:

- Cuándo está indicada la inducción.
- Cómo se evalúa el cuello (Bishop).
- Qué métodos se usan y cuándo están contraindicados.
- Cuándo una inducción se considera fallida.

2. Fisiología y bases conceptuales

El trabajo de parto espontáneo es resultado de una serie de **cambios bioquímicos y hormonales**:

- Aumento de **receptores de oxitocina y prostaglandinas** en el miometrio y el cuello uterino.
- Degradación de colágeno y maduración cervical.
- Aumento del calcio intracelular que facilita la contracción muscular.

La inducción busca **reproducir estos procesos fisiológicos de forma controlada**, ya sea:

- **Madurando el cuello** (prostaglandinas o métodos mecánicos).

- Estimulando contracciones uterinas (oxitocina o amniotomía).
-

3. Indicaciones de inducción del parto (MINSAL 2023)

A. Maternas

- Hipertensión gestacional o preeclampsia leve con feto maduro.
- Diabetes gestacional controlada (≥ 39 semanas).
- Rotura prematura de membranas (RPM) >37 s sin trabajo de parto.
- Corioamnionitis.
- Compromiso materno (cardiopatía, nefropatía, etc.) con feto viable.

B. Fetales

- Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) con flujo Doppler alterado y feto maduro.
 - Embarazo prolongado (>41 semanas).
 - Óbito fetal.
 - Oligoamnios o líquido meconial espeso con madurez pulmonar.
-

4. Contraindicaciones

A. Absolutas (parto vaginal contraindicado)

- Desproporción cefalopélvica evidente.
- Placenta previa o vasa previa.
- Presentación transversa.
- Prolapso de cordón.

- Cirugía uterina previa con incisión clásica o ≥ 2 cesáreas previas.
- Carcinoma de cérvix invasor.

B. Relativas

- Sufrimiento fetal agudo (requiere cesárea).
- Presentación podálica.
- Polihidroamnios.
- Macrosomía (>4.500 g).
- Hipersensibilidad a prostaglandinas (en inducción farmacológica).

☐ EUNACOM suele preguntar cuál de las siguientes NO es indicación o cuál es contraindicación absoluta.

5. Evaluación previa:

Índice de Bishop

Evalúa la **madurez cervical** y predice la probabilidad de éxito de la inducción.

Parámetro	0	1	2	3
Dilatación (cm)	0	1–2	3–4	≥ 5
Borramiento (%)	0–30	40–50	60–70	≥ 80
Consistencia	Firme	Media	Blanda	—
Posición	Posterior	Media	Anterior	—

Altura presentación -3 -2 -1 / 0 +1 / +2

Interpretación:

- **≥8 puntos:** cuello favorable → alta probabilidad de parto vaginal.
- **<6 puntos:** cuello desfavorable → requiere maduración cervical previa.

☐ En caso EUNACOM clásico: “Bishop 3” → usar prostaglandinas antes de oxitocina.

6. Métodos de inducción

Se clasifican en **mecánicos**, **farmacológicos** y **combinados**.

A. Métodos mecánicos

1. Despegamiento de membranas

- Separación de la membrana amniótica del segmento inferior.
- Estimula liberación local de prostaglandinas.
- Indicado si cuello parcialmente maduro.
- Contraindicado en placenta previa o RPM.

2. Catéter de Foley intrauterino

- Se inserta balón de 30–60 mL a través del cérvix.
 - Provoca dilatación mecánica y liberación de prostaglandinas endógenas.
 - Ideal en Bishop <6, especialmente en cesárea previa (seguro).
-

B. Métodos farmacológicos

1. Prostaglandinas (maduración cervical y contracciones)

Fármaco	Dosis y vía	Indicaciones	Comentarios
Dinoprostona (PGE₂)	Gel intracervical 0,5 mg cada 6 h (máx 3 dosis)	Bishop desfavorable	No usar en cicatriz uterina
Misoprostol (PGE₁)	25 µg intravaginal cada 4–6 h (máx 6 dosis)	Bishop <6, RPM sin dinámica	Contraindicado en cesárea previa o hiperestimulación

Efectos adversos: taquisistolia, hiperestimulación uterina, fiebre, vómitos.

- ☐ En hospitales públicos chilenos, **misoprostol vaginal** es el método más utilizado para maduración cervical en Bishop bajo.

2. Oxitocina (inducción del trabajo activo)

Se administra cuando el cuello es favorable (Bishop ≥6).

- **Dosis inicial:** 2 mU/min, aumentar cada 30 min hasta contracciones efectivas (3–5/10 min).
- **Dosis máxima:** 40 mU/min.
- Diluir en 500 mL de SG5% o Ringer Lactato.
- Monitorización continua de FCF y dinámica uterina.

Objetivo: lograr contracciones regulares sin hiperdinamia.

- ☐ Suspender inmediatamente si hay **>5 contracciones/10 min** o **desaceleraciones fetales tardías**.

C. Métodos combinados

- **Amniotomía + oxitocina:** en Bishop favorable y membranas íntegras.
- Permite monitorización directa del líquido amniótico y acelera el trabajo de parto.

Contraindicado si la presentación no está encajada (riesgo de prolapso de cordón).

7. Inducción fallida

Definición (MINSAL 2023):

No inicio de trabajo de parto activo (dilatación ≥ 4 cm y borramiento $\geq 80\%$) tras 24 horas de inducción adecuada con prostaglandinas u oxitocina.

Conducta:

- Reevaluar desproporción cefalopélvica.
 - Si feto y madre estables → repetir inducción al día siguiente.
 - Si persistente → **cesárea**.
-

8. Complicaciones

Complicación	Causa	Manejo
Hiperestimulación uterina	Exceso de oxitocina o prostaglandinas	Suspender fármaco, oxígeno, posición lateral, tocolítico
Sufrimiento fetal agudo	Hipoxia secundaria a hipertonía	Interrupción inmediata
Rotura uterina	Uso de prostaglandinas en cicatriz uterina	Cesárea urgente
Infección intraamniótica	RPM prolongada	Antibióticos y parto

Fracaso de inducción

Cuello inmaduro, pelvis estrecha

Cesárea

9. Monitoreo durante la inducción

- **Frecuencia cardíaca fetal (FCF):** cada 15–30 min (continua si oxitocina).
- **Contracciones:** cada 10 min (clínica o tocodinamómetro).
- **PA y pulso materno:** cada 30 min.
- **Evitar hiperestimulación** (>5 contracciones/10 min o >90 s de duración).

10. Casos típicos EUNACOM

Ejemplo 1:

Gestante de 41 s, Bishop 8, sin contracciones → conductas: **amniotomía + oxitocina**.

Ejemplo 2:

Gestante de 39 s, Bishop 3, hipertensión leve → **misoprostol vaginal 25 µg**.

Ejemplo 3:

Gestante con cesárea previa, Bishop 2 → **catéter de Foley (no prostaglandinas)**.

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. La **inducción del parto** busca iniciar contracciones uterinas regulares y efectivas.
2. **Evaluar Bishop:** <6 → maduración cervical; ≥6 → oxitocina directa.

3. **Misoprostol** contraindicado en útero con cicatriz previa.
4. **Oxitocina:** iniciar 2 mU/min y aumentar progresivamente.
5. **RPM ≥ 37 s:** inducción inmediata si no hay contracciones.
6. **Inducción fallida:** no progresión tras 24 h → reevaluar o cesárea.
7. **Monitoreo continuo** para detectar hiperdinamia o sufrimiento fetal.



Errores comunes

- Usar prostaglandinas en paciente con cesárea previa.
- Administrar oxitocina sin Bishop adecuado.
- No suspender oxitocina ante hiperdinamia.
- Iniciar inducción sin verificar presentación encajada.
- No considerar la edad gestacional o condición fetal antes de inducir.

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Inducción del parto:** estimulación artificial de contracciones para lograr parto vaginal.
2. **Indicaciones:** embarazo prolongado, preeclampsia, RPM, diabetes, RCIU.
3. **Bishop < 6 :** requiere maduración cervical (prostaglandinas o Foley).
4. **Bishop ≥ 6 :** usar oxitocina $\pm$ amniotomía.
5. **Contraindicación absoluta:** placenta previa, cesárea clásica, presentación transversa.
6. **Misoprostol:** útil en Bishop bajo, pero contraindicado en útero cicatricial.
7. **Inducción fallida:** tras 24 h sin fase activa → cesárea.